

D03. 당뇨 초진

1줄 요약: 당뇨 초진 = 확진 + 응급 배제 + 병형 감별 + 합병증 스크리닝 + 치료/교육 + 추적예약

2026.05 · 교육용 초안 · 실제 처방/청구는 최신 진료지침·병원 EDI·심평 급여기준 확인

1. 초진에서 먼저 가르는 4가지 질문

Q1	당뇨가 맞나?	진단기준 충족 여부 · 재확인 필요성 판단
Q2	오늘 응급인가?	DKA/HHS · 탈수 · 의식변화 · 감염 · 급성 심혈관 배제
Q3	2형으로 봐도 되나?	1형/LADA · 췌장질환 · 약제성 · 내분비 질환 감별
Q4	이미 손상된 장기가 있나?	눈·콩팥·신경/발·심혈관 — 초진부터 스크리닝

Tip: 검진표 HbA1c 6.6%만 보고 "약만 시작"하지 않는다. 증상·이전 수치·빈혈/CKD/수혈·약제·체중 변화·케톤/탈수까지 확인

2. 진단 기준 & 한국 국가검진 흐름

검사	당뇨 기준	해석 포인트
HbA1c	6.5% 이상	NGSP 표준화. 빈혈/용혈/수혈/CKD에서 실제 혈당과 어긋남
공복혈당(FPG)	126 mg/dL 이상	8시간 이상 금식 후 정맥혈. 검진 전날 야식/음주 확인
OGTT 2시간	200 mg/dL 이상	임신/경계 등 특수상황. 일반 외래 초진 선택적
무작위혈당+증상	200+다뇨/다음/체중감소	탈수/의식변화 동반 → 당일 응급 평가 우선

한국 검진 실천 흐름

- 국가검진 공복혈당 100+ 또는 회사검진 HbA1c 이상 소견 → 우리 병원에서 FPG+HbA1c 재확인 (회사검진 수치 그대로 믿지 않기)
- HbA1c 5.7-6.4% + FPG 100-125 → 당뇨병전단계: 생활중재 + 3-6개월 추적
- HbA1c 6.5% 또는 FPG 126 이상 → 명백한 고혈당 증상 없으면 다른 날 재확인 원칙
- 명백한 증상(다뇨/다음/체중감소) 동반 → 당일 확진 가능, 급성 위험 배제 후 치료 시작

3. 레드 플래그 — 당일 놓치면 안 되는 위험 신호

범주	의심 단서	당일 행동
DKA / HHS	오심/구토/복통, 탈수, Kussmaul 호흡, 의식저하, 매우 높은 혈당	케톤+전해질+산증 확인 → 응급실
1형/LADA 의심	마른 체형, 빠른 체중감소, 케톤, 젊은 발병, 자가면역질환 병력	C-peptide/GAD항체 → 내분비 의뢰
심한 감염/발 병변	발 궤양, 봉와직염, 괴사, 말초혈관질환 의심	항생제/영양/혈관평가 → 응급/상급 의뢰
급성 심혈관/신경	흉통, 호흡곤란, 신경학적 결손, 실신	당뇨 평가보다 응급 평가 우선

4. 초진 오더 세트

목적	검사	메모
진단 확인	HbA1c, FPG (또는 무작위혈당)	검진표 날짜·검사기관·공복 여부 확인
약제 안전성	Cr/eGFR, AST/ALT, 전해질, CBC	Metformin/SGLT2i 시작 전 기준 확보

심혈관 위험	지질(TC/LDL/HDL/TG), 혈압, BMI	스타틴·혈압 관리 계획 동시 수립
신장 합병증	소변 ACR, eGFR, 요검사	ACR 단회 이상 시 반복 확인 필요
급성 위험(해당 시)	소변/혈중 케톤, bicarbonate	심한 고혈당·체중감소·구토/탈수 때
합병증 의뢰	안과 의뢰, 발(10g monofilament), ECG	"나중에"가 아니라 초진 루틴으로 — 누락 방지

5. 첫 치료 결정 로드맵

0	응급 여부	케톤/산증/탈수/의식저하/흉통 → 외래 처방 전 응급 평가
1	병형 확인	전형적 2형 vs 1형/LADA/체강성/약제성 감별
2	A1c + 증상	A1c·혈당·증상·체중감소·케톤 → 단독/병합/주사 결정
3	동반질환	ASCVD/HF/CKD/비만/고령/저혈당위험/비용 반영해 약제 선택
4	추적 예약	1-4주(부작용/혈당) + 3개월(HbA1c) — 초진 당일 예약 완료

상황	초기 접근
HbA1c 목표 근접, 무증상	생활중재 4주 관찰 후 Metformin(다이아벡스엑스알 500mg bid) 시작
HbA1c 7.5-9%	초기 병합요법 고려. 환자 선호·비용·저혈당 위험·체중 목표 반영
HbA1c >=10% 또는 혈당 >=300, 케톤/증상	인슐린 필요성 평가. DKA/HHS 의심 → 응급실
ASCVD 고위험/확진	GLP-1 RA 또는 SGLT2i 우선 (심혈관 이득 입증)
심부전 또는 CKD	SGLT2i 적응증·신장기능·급여 확인. 진행 CKD → 신장내과 협진
고령/frailty/저혈당 위험	과도한 목표 회피. SU/인슐린 시 저혈당 교육 + 완화 목표

6. 약제별 포인트 — 한국 상품명 포함

약제군	주요 상품명(한국)	좋은 상황	주의
Metformin	다이아벡스엑스알 (500/750/1000mg) 글루코다운OR정	전형적 2형, 비용 부담, 체중 유지	위장 부작용 → XR 제형 변경. eGFR <30 금기. B12 결핍 장기 추적
SGLT2i	포시가 10mg 자디앙 10/25mg 슈글렛정	HF, CKD, ASCVD, 체중/혈압 이득	생식기 감염, euglycemic DKA, 수술/금식/급성질환 시 중지. 급여: Metformin 실패 후 병용, HF/CKD 적응증은 혈당 무관 급여
GLP-1 RA	트루리시티(주1회) 오젠퍹(주1회) 위고비(비만) 마운자로(주1회)	비만, ASCVD 위험, 강한 A1c/체중 감소	오심/구토, 체강염/담낭 병력. 갑상샘 수질암/MEN2 금기. 비급여 시 월 30-50만원 — 비용 상담 필수
DPP-4i	자누비아(시타글립틴) 트라젠타(리나글립틴) 가브스(빌다글립틴)	고령, 저혈당 회피, 주사 거부	신기능별 용량 조정(리나글립틴 불필요). GLP-1 RA와 병용 이득 부족. 삭사글립틴: 심부전 주의
SU	아마릴(글리메피라이드) 다이아미크론MR (글리클라지드)	비용 제한, 빠른 혈당 강하	저혈당·체중 증가. 고령/불규칙 식사/CKD 주의. 글리벤클라마이드(다오닐) 노인 금기
Insulin	란투스/트레시바 (기저인슐린) 노보래피드/휴마로그 (초속효성)	증상성 고혈당, 케톤, A1c 매우 높음, 1형 의심	자가혈당+저혈당 대처+주사 교육 필수. 용량조절 계획 수립

SGLT2i 급여 핵심: (1) Metformin 실패 후 병용 → 급여 / (2) 심부전(HFrEF/HFpEF) 적응증 — 혈당 무관 단독 급여(포시가·자디앙) / (3) CKD 적응증(eGFR 기준 확인) / GLP-1 RA 급여 제한 — 처방 전 확인 필수

7. 의뢰 기준 (Refer)

의뢰처	기준
응급실	DKA/HHS, 의식변화, 심한 탈수/구토, 급성 흉통/뇌졸중, 중증 감염/괴사성 발 병변
내분비내과	1형/LADA 의심, 반복 케톤, A1c 높고 조절 불량, 복잡한 인슐린 시작, 이차성 당뇨 의심
안과	2형 당뇨 진단 시 안저 평가 (진단 시점부터 루틴). 시력저하/비문증/망막병증 의심

신장내과	eGFR 감소 진행, ACR 지속 상승, 혈뇨/비전형 신장질환, 조절 어려운 고혈압
혈관/정형/상처	발 궤양, 감염, 말초동맥질환, Charcot 의심, 감각저하+변형 동반
영양/당뇨교육	식사 조절 실패, 저혈당 반복, 인슐린/SU 사용, 건강문해력 낮음

8. 생활교육 핵심 + 환자 설명 스크립트

항목	첫날 핵심 메시지
식사	단 음료/주스/믹스커피/야식부터 줄이기. 밥·면·빵·과일은 "금지"보다 양과 시간 규칙
운동	식후 10-20분 걷기부터 시작. 목표: 주 150분 유산소 + 주 2-3회 근력
체중	5-10% 감량만으로 혈당·혈압·지방간·지질 함께 개선 가능
저혈당 대처	식은땀/떨림/두근거림 → 당 15g (각설탕 3개 / 주스 반 컵) + 15분 후 재측정
자가혈당	인슐린/SU 사용, 증상성 고혈당, 약 조정 중 → 시간대별 기록 교육
Sick day	구토/탈수/식사 불가 시 SGLT2i·Metformin 임시 중단 + 의료기관 연락

환자 설명 스크립트

"당뇨는 단 음식 때문에 생긴 병이 아니라, 몸이 혈당을 처리하는 능력이 떨어진 상태입니다. 치료 목표는 숫자를 낮추는 것뿐 아니라 눈·콩팥·심장·발을 오래 지키는 것입니다.

처음 3개월은 약이 맞는지, 식사/운동이 지속 가능한지, 합병증 검사가 빠지지 않았는지 같이 조정하는 기간입니다.

약 드시다가 속이 불편하거나 혈당이 낮아지는 느낌이 있으면 다음 예약 전이라도 연락 주세요."

9. 미니 케이스 — 한국 1차 진료 실전

케이스	상황	핵심 접근
Case 1	40대 직장인, 회사검진 HbA1c 6.8%, 무증상 내원	검진일/공복 확인 → FPG+HbA1c 재확인 → eGFR/지질/ACR/발·안저 계획 → 생활중재 4주 → 다이나 벅스엑스알 500mg bid 시작 → 3개월 재평가
Case 2	HbA1c 10.8%, 6kg 감소, 구갈/야간뇨, BMI 21 마른 체형	2형 단정 금지 → 케톤/전해질/산증 당일 평가 → C-peptide/GAD항체 채혈 → 인슐린 필요성 평가 → 내분비내과 의뢰
Case 3	HbA1c 8.2%, eGFR 55, ACR 상승, 심부전(HFrEF) 병력	포시가 10mg 또는 자디앙 10mg — 심부전 적응증 급여 가능 → ACR 반복 확인 → 신장내과 협진 고려
Case 4	60대, 혈압약 복용, HbA1c 7.2%, 혈압 148/92	ARB+SGLT2i로 혈압·신장·혈당 동시 이득 고려 → 지질(스타틴 필요성) → Metformin + 트라젠타(신장 용량 조정 불필요) 병합 옵션

10. 복사해서 쓰는 EMR 템플릿 (D03)

[D03 당뇨 초진 EMR 템플릿]

CC/방문이유: 검진결과/증상/타원의회 —

진단근거: HbA1c __% (검사일: __, 기관: __) / FPG __ mg/dL / 증상 (해당:) / 재확인 여부:

급성위험: 구토/복통/탈수/의식변화/케톤: __ / 당일 응급 여부:

병형 감별: 2형 가능성 / 1형/LADA/이차성 의심 단서: __ / 추가검사(C-peptide/GAD/IA-2):

동반질환: BP __ / BMI __ / 흡연: __ / ASCVD/HF/CKD/HTN/DLP/지방간:

합병증: 눈(안과의회 __) / 신장(eGFR __ / urine ACR __) / 발(피부/궤양/맥박/monofilament/진동감각 __)

초진 검사: HbA1c, glucose, CMP(Cr/eGFR/AST/ALT/electrolyte), lipid, CBC / urine ACR, UA+ketone

치료: 생활교육(식사/운동/체중/음주/흡연) / 약제: __ (선택이유: __) / 저혈당/부작용/sick day 교육:

추적: 1-4주(부작용/혈당) / 3개월(HbA1c) / 의뢰(안과/내분비/신장/영양):

심평/차팅 Tip: "당뇨 교육함" 한 줄 대신 진단 근거·검사 계획·합병증 스크리닝·약제 선택 이유·부작용/저혈당 교육 내용·추적 계획을 구체적으로.

KCD: 합병증 확인 시 E11.2(신장)/E11.3(눈)/E11.4(신경) 세부 코드 반영

11. 심플 총정리

진단	HbA1c/FPG 기준 알고 명백하지 않으면 재확인. 회사검진 수치 그대로 믿지 말기
위험	케톤·탈수·의식변화·체중감소·구토/복통 → 당일 평가
검사	A1c만 보지 말고 eGFR·ACR·지질·간기능·발·안저를 초진 세트로

약제	Metformin 자동 대신 ASCVD/HF/CKD/비만/저혈당 위험 반영. 상품명 확인
급여	SGLT2i: Metformin 실패 후 병용 or HF/CKD 적응증. GLP-1 RA 급여 제한적
교육	단 음료·식후 걷기·저혈당 대처·sick day·발 관리부터 반복
추적	초진 당일 1-4주 + 3개월 예약까지 완료

참고: ADA Standards of Care 2026 · 대한당뇨병학회 진료지침 · 심평원 요양급여기준 · 병원 EDI 코드 확인 필수

교육용 자료 (초안) · ClinicNote D03 당뇨 초진 · 2026.05 · 실제 처방/청구는 환자 상태·병원 프로토콜·최신 진료지침·심평/EDI 기준 확인
